

gering en wordt de therapie goed verdragen. Dat komt doordat de patiënt alleen in de eerste maanden de combinatie ipilimumab en nivolumab krijgt en daarna doorgaat met nivolumab alleen.”

Bij de combinatie pembrolizumab en axitinib hebben mensen meestal niet zo zeer die immunologische bijwerkingen. Maar zijn er wel bijwerkingen van axitinib en omdat die behandeling doorgaat zijn er ook veel chronische bijwerkingen. Bijwerkingen zoals vermoeidheid en verminderde eetlust.

“Bijkomend argument zijn de kosten”, vervolgt Ronald de Wit. “De combinatie-immunotherapie is dan uiteindelijk voordeliger dan de combinatietherapie pembrolizumab en axitinib. Vooral ook omdat die axitinib zo lang wordt voortgezet en dat is een duur middel.”

“Omwille van bijwerkingen en kosten kun je zeker wel een lans breken om toch vast te houden aan de combinatie-immunotherapie nivolumab en ipilimumab.”

Ook in de studie CheckMate 9ER, die werd gepresenteerd tijdens het in september gehouden ESMO congres, is een combinatie met immunotherapie en TKI onderzocht. In deze studie werden de middelen nivolumab en cabozantinib vergeleken met sunitinib. Ronald de Wit: “Ook deze studie toonde overlevingswinst bij alle drie de patiëntgroepen. En ook hier was de winst bij de subgroepen met intermediaire en ongunstige prognose overduidelijk en bij de subgroep met goede prognose was deze winst beperkt. De last

van bijwerkingen is bij deze combinatietherapie iets gunstiger omdat de dosis van cabozantinib wat lager is gegeven dan gebruikelijk. En dat maakt dat patiënten het wat beter verdragen.”

Op dit moment loopt in een aantal Nederlandse ziekenhuizen de studie COSMIC-313. Dit gaat om een eerstelijnsbehandeling bij uitgezaaid heldercellig niercelcarcinoom. De studie vergelijkt de combinatie nivolumab, ipilimumab en cabozantinib versus nivolumab en ipilimumab alleen.

Conclusie ontwikkelingen

“De mogelijke behandelingen bij uitgezaaide nierkanker zijn dus behoorlijk aan verandering onderhevig”, concludeert Ronald de Wit. “Eerst was het sunitinib alleen. Toen kwam er nivolumab bij en later ipilimumab.”

Op dit moment kiezen de meeste centra voor de combinatie-immunotherapie nivolumab en ipilimumab bij patiënten met een intermediaire en ongunstige prognose. Bij patiënten met de gunstige prognose blijft de standaardbehandeling een TKI zoals sunitinib of pazopanib.

“Die hoeveelheid aan mogelijke behandelingen maakt dat een arts voldoende kennis en ervaring moet hebben om een goede keuze te kunnen maken voor de behandeling van een patiënt. Vanwege de aard van de bijwerkingen van die combinatie-immunotherapie kan dat het beste gebeuren in één van de 14 ziekenhuizen die ook immunotherapie bij melanoom geven”, adviseert Ronald de Wit.

Patiënten met een gunstige prognose bij uitgezaaide nierkanker kunnen voor hun behandeling met sunitinib op pazopanib prima terecht in hun eigen ziekenhuis.